

【제 목】 : 심사 사후관리 범위 확대에 관한 방안마련 필요(시정, 권고)
【내 용】

- 심사관리실은 「요양급여비용 심사·지급업무 처리기준」 제4조 및 「심사사후관리 업무처리규정」에 따라 요양급여비용의 심사·지급 후 관련 법령과 공개된 심사기준에 의한 적합성을 검토하고 필요시 사후 정산하는 심사사후관리 업무를 담당하고 있다.
- 사후관리 항목은 **【표 1】** ‘심사사후관리 항목’에서와 같이 요양급여 비용 지급 전 심사단계에서는 수진자·진료기간별 또는 요양기관 간 연계가 되지 않아 확인이 곤란한 건을 대상으로 선정하며, 항목 별로 정해진 점검주기에 따라 사후관리를 실시하고 있다.

【표 1】 심사사후관리 항목(2017년 기준)

사후관리 사유	사후관리 항목	점검주기
환자별·진료기간별 누적점검	동일성분 의약품 중복처방 점검	분기
	비자극검사 산정횟수 점검	년
	치면열구전색술 산정횟수 점검	년
	입원진료비용 중복청구 점검	반기
	자보·건보 중복청구 점검	분기
	굴밀도검사료 점검	년
	초음파 검사 산정횟수 점검	년
요양기관 간 연계확인	위탁진료비용 중복청구 점검	년
	의과·한의과협진 중복 점검	분기
	원외처방 미연계건 사후연계	월
	약국본인부담률 착오적용(V252)(조제기관)	년
	약국본인부담률 착오적용(V252)(처방기관)	년
	처방조제 상이내역 점검	월
청구오류 다발생	항목별 재점검	월
	의과 청구착오 재점검	월
	중환자실 간호관리료 차등제	년

- 한편, 요양기관으로부터 접수된 모든 청구명세서는 심사부서에 분배되기 전 단가, 코드 등의 기본사항을 점검하고 정형화 가능한 전산로직을 적용하는 전산점검(심사) 절차를 거치게 되는데 이 절차는 총 8단계로 구성되어 있다.

【그림 1】 전산심사 업무 흐름도



- 이 중, 약제, 상병 및 심사기준 전산심사 등은 약제 허가사항 및 상병, 심사기준(고시)을 일정한 틀의 로직으로 설계하여 명세서에 청구된 항목들을 전산으로 심사하고 조정하는 과정으로,
 - 전산으로 명세서 특성들을 모두 고려하여 심사하는 것은 불가능하고, 전산심사 로직 구현의 효율성을 높이고 심사 오류율을 감소시키기 위해서 매우 명확한 항목만 조정하도록 넓은 범위로 로직을 설계하거나 심사 조정 대신 메시지를 발생하여 직원이 확인 후 심사하도록 하고 있다.
- 심사관리부는 최근 심사사후관리범위를 ‘연계관리가 필요한 항목’이라는 기존 기준에만 국한하지 않고 사후관리 점검영역을 확대하기 위해 적극적으로 신규항목을 개발하고 있으며,
 - 【표 2】 ‘심사 사후관리 점검영역 확대관련 신규 개발항목’에서와 같이 전산심사 범위가 다소 넓어 조정이 반영되지 않았던 ‘리도카인(주)

마취 시 주사 수기로 별도 청구건, '멸균드레싱 류 급여기준 초과건'을 심사 사후관리 항목으로 추가 발굴하여 검토 중에 있다.

【표 2】심사 사후관리 점검영역 확대 관련 신규 개발항목

연번	항목명	세부내용
1	리도카인(주) 마취 시 주사 수기로 별도청구건 점검	▶ 외래명세서 ▶ 리도카인주 마취 및 신경차단술 등에 타 주사제가 없음에도 마1(KK010) 피하 또는 근육내 주사료 등 별도 청구건
2	멸균드레싱 류 급여기준 초과건 점검	▶ 외래명세서 ▶ 인정기준 관련 상병 및 수가 외의 명세서에 청구된 멸균 드레싱 * 인정범위: Central Venous Catheter(PICC,Port포함) site Skin Graft Donor site

주. 「심사 사후관리 운영강화 추진계획(안) 보고」 (심사관리부-534호, 2018.02.20.)

- 이에, 감사기간동안 정밀한 기준을 적용하기에는 다소 불확실한 위험요소가 존재하여 넓은 범위로 전산 적용되어 있어 심사 사후관리 항목으로 추가 개발 가능한 항목을 검토한 결과,
- 「외래 항암주사관리료의 인정기준」에 따르면 해당 항목은 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 의한 산정특례 대상 중 등록 암환자(V193)와 미등록 암환자(V027)에 대하여 외래에서 항암제를 투여한 경우 1일 1회 산정할 수 있으며, 「요양급여비용, 청구방법 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 따라 해당 수가를 청구할 경우에는 특정내역코드 MT002에 'V027' 또는 'V193'을 기재하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【외래 항암주사관리료의 인정기준】**

외래 항암주사관리료는 아래와 같은 요건을 모두 충족한 경우 인정함.	
가. 산정대상	「 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 」에 의한 산정특례 대상 중 등록 암환자(V193)와 미등록 암환자(V027)에 대하여 외래 진료 가 이루어진 경우
나. 산정기준	(1) 외래주사실 에서 항암제를 정맥내점적주입 방법으로 투여 받는 환자에게 최소한 30분 이상 관찰한 경우 1일 1회 산정함 (2) 동일일 입원료를 산정하는 경우에는 입원료에 이미 관리비용 등이 포함되어 있으므로 별도로 외래 항암주사관리료를 산정할 수 없음
(시행일 : 2015.9.1)	

☞ **참고자료: 【요양급여비용,청구방법 심사청구서·명세서식 및 작성요령】**

특정내역 구분코드	특정내역	작성요령 및 기재형식
MT002	특정기호(*)	만성신부전증환자, 암환자, 조혈모세포이식대상질환자, 혈우병 환자, 장기(간장,췌장,심장)이식환자 등 별표6.“특정기호코드”의 사항에 해당되는 기호를 기재

- 2017년 1월부터 감사일 현재까지 항암제 청구가 없거나 산정횟수를 초과하였거나 특정내역을 기재하지 않는 등 급여기준을 초과하여 청구된 외래 항암주사관리료는 총 ***건, 총 ***원으로 발생한 사실을 확인하였다.
- 상기 건은 ‘비용 지급 전 확인이 곤란한 사항’에 해당되지 않아 실제적으로 심사 사후관리 항목의 전형적인 특성을 갖고 있다고 볼 수는 없으나,
 - 심사 사후관리 점검영역 확대라는 최근 심사관리부의 업무 방향성을 고려할 때 해당 항목을 검토 후 필요시 신규 사후관리 항목으로 적용하는 등 심사의 정확성 및 일관성 제고 및 재정누수 방지를 통해 보험재정 건전화 달성 방안을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- ① ‘외래 항암주사관리료’의 사후관리 항목으로의 적용 가능성을 검토하여 필요시 신규 대상으로 선정하시고,
- ② 급여기준을 초과하여 청구된 외래 항암주사관리료 총 ****건, 총 *****원을 환수하시기 바랍니다.